ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

0796 222 597 / 0663 755 584

Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi

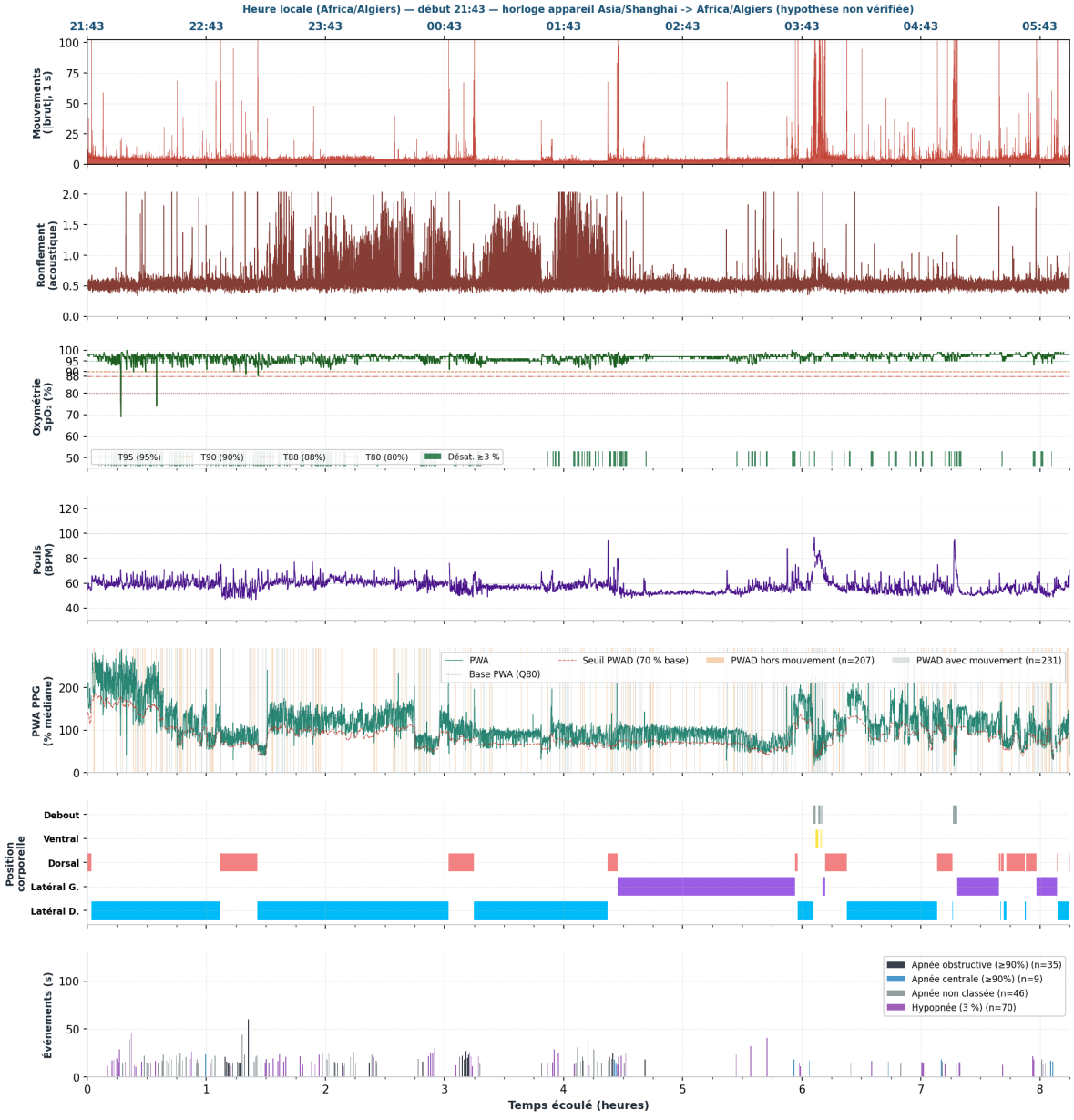
en face des urgences, Guelma

selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENTE

Nom :	Boussioud Habiba	**ID Patient :**	20261103-149
Genre :	Femme	**Âge :**	66 ans (Née le 03/11/1960)
Taille / Poids :	157 cm / 69 kg	**IMC :**	28,0 kg/m^2 (Surpoids)
Date examen :	02 – 03/11/2026	**Indication :**	Bilan suspicion SAOS
Heure de début :	**21 :37 :00**	**Heure de fin :**	**07 :44 :30**
Durée enreg. :	607,5 min (10 h 08)	**Durée valide :**	607,5 min (100 %)

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE



v9.9-hb | 20261029-148.EDF | sha256 aeac1c69d9e8 | dénominateur : temps d'enregistrement (TRT)

FIGURE 1 – **Analyse chronologique polygraphique et des événements physiologiques (21 :37 – 07 :44).**

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS

Table 1 – **Répartition posturale et distribution des événements respiratoires et oxymétriques**

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	415,6	68,4	72	19	11	–	199	28,7	301
Ventrale (PRO)	2,9	0,5	–	–	–	–	–	–	–
Côté gauche (LAT-G)	85,3	14,0	1	1	–	–	21	14,8	23
Côté droit (LAT-D)	97,4	16,0	6	2	–	–	9	5,5	17
Debout (Éveil)	6,4	1,1	–	–	–	–	–	–	–

2.2. ÉVÉNEMENTS SpO_2

Table 2 – **Profil oxymétrique nocturne (critère de désaturation $\geq 3\,\%$)**

Paramètre SpO_2	Valeur	Valeur de référence
SpO_2 max (%)	99	95 – 100 %
SpO_2 min (%)	**87**	$\geq$ 90 %
SpO_2 moyenne (%)	95	$\geq$ 95 %
Durée totale de désaturation (min)	149,1	—
Durée moyenne de désaturation (sec)	39,1	—
Durée maximale de désaturation (sec)	119,0	—
Nombre total de désaturations (DO)	229	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	**22,6 /h**	$<$ 5 /h
Temps passé sous 95% : T95 (min / %)	299,2 min	49,3 %
Temps passé sous 90% : T90 (min / %)	**2,0 min**	**0,3 %**
Temps passé sous 85% : T85 (min / %)	–	0,0 %
Temps passé sous 80% : T80 (min / %)	–	0,0 %

IDO et pourcentages de temps cumulés (T95, T90, T85, T80) calculés sur le temps d'enregistrement valide (607,5 minutes).

2.3. INFORMATIONS DU POULS

Table 3 – **Analyse de la fréquence de pouls / cardiaque**

Paramètre Pouls / Fréquence Cardiaque	Valeur (bpm)
Fréquence cardiaque maximale (FC max)	139
Fréquence cardiaque minimale (FC min)	63
Fréquence cardiaque moyenne (FC moy)	83,1

2.4. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (AP & HYPO)

TABLE 4 – **Détail et quantification des événements respiratoires**

Paramètre Respiratoire	Valeur	Indice (/h)
Apnées (AP)		
Nombre total	33	
– Obstructives (SAOS)	22	(2,2)
– Centrales (AC)	11	(1,1)
– Mixtes (AM)	0	(0,0)
Durée totale (min)	8,6	
Durée moyenne (sec)	15,6	
Durée maximale (sec)	34,2	
Hypopnées (HYPO)		
Nombre total	79	
Durée totale (min)	29,3	
Durée moyenne (sec)	22,2	
Durée maximale (sec)	96,0	
Total Événements Respiratoires (TER)		
Nombre total (AP + HYPO)	112	—
Durée totale (min)	37,8	—
Durée moyenne (sec)	20,3	—
IAH (Indice Apnées-Hypopnées)	—	**11,1**
IDO (Index Désaturations)	—	**22,6**
IMR / RDI (Respiratory Disturbance Index)	—	**11,1**

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS CLÉS

TABLE 5 – **Synthèse générale des paramètres polygraphiques**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
SpO_2 moyenne (%)	95	SpO_2 minimale (%)	**87**
IDO (/h)	**22,6**	Nombre SAOS	22
Nombre AC	11	Nombre AM	0
IA (/h)	3,3	Nombre HYPO	79
IH (/h)	7,8	**IAH (/h)**	**11,1**
IMR / RDI (/h)	11,1	Index Ronflements (/h)	4,2
FC moyenne (bpm)	83,1	Nb changements position	**176**

4. AVIS MÉDICAL

4.1. Interprétation

Polygraphie ventilatoire valide de **607,5 min** (21h37 – 07h44, heure d'Algérie). Sans EEG, le temps de sommeil n'est pas mesuré : les indices sont rapportés au temps d'enregistrement.

— **Sévérité :** IAH = **11,1 /h** (intensité légère, 5 – 14,9 /h), dominé par les hypopnées (79 sur 112 événements ; IH = 7,8 /h). Apnées : 22 obstructives (2,2 /h), 11 centrales (1,1 /h), aucune mixte.

— **Composante positionnelle probable :** 68,4 % du temps en décubitus dorsal. IAH dorsal = **14,7 /h** contre **3,3 /h** en décubitus latéral (rapport 4,5 ; LAT-G 1,4 /h, LAT-D 4,9 /h). Les 11 apnées centrales sont toutes dorsales. À confirmer : LAT-D proche de 5 /h et seulement 10 événements hors décubitus dorsal.

— **Oxymétrie :** SpO_2 moyenne 95 %, minimale 87 %, T90 = 0,3 % : pas d'hypoxémie prolongée. L'IDO (**22,6 /h**) dépasse l'IAH, ce qui peut refléter des limitations de débit, des désaturations non obstructives ou des artéfacts de mouvement ; l'IDO dorsal atteint 28,7 /h.

— **FC et mouvements :** FC moyenne 83,1 bpm, pic à 139 bpm. 176 changements de position (≈ 17,4 /h) ; la fragmentation du sommeil n'est pas évaluable sans EEG.

4.2. Conclusion

— **IAH = 11,1 /h, compatible avec un SAOS léger**, à corréler à la clinique (symptômes, comorbidités).

— **Phénotype positionnel** (IAH dorsal 14,7 /h versus latéral 3,3 /h).

— **Composante centrale mineure** (IAC = 1,1 /h), uniquement dorsale.

— **Désaturations intermittentes** (IDO = 22,6 /h) sans hypoxémie prolongée (T90 = 0,3 % ; nadir = 87 %).

Conduite à tenir :

1. Dispositif anti-décubitus dorsal en première intention avec contrôle d'efficacité .

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24